

Fragen und Antworten zur Diagnosen- und Leistungscodierung im extramuralen ambulanten Bereich

Stand: 19. Dezember 2025

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
(BMASGPK)

Stubenring 1, 1010 Wien

Herstellungsort: Wien

**Die Erarbeitung dieser Unterlage erfolgte im Rahmen des Projekts "Ambulante
Diagnosencodierung" in Verbindung mit dem Projekt "Leistungsorientierte
Krankenanstaltenfinanzierung (LKF)"**

Projektleitung:

Mag. Stefan Eichwalder (BMASGPK)

Projektteam

BMASGPK:

Wolfgang Bartosik, Werner Bohuslav, Romana Höltschl, MSc, Mag. Rainer Kleyhons,
Mag. Walter Sebek (Endredaktion)

Koordination medizinische Dokumentation:

Dr. Andreas Egger (BMSGPK), Anna Mildschuh (SOLVE-Consulting)

Ökonomenteam (SOLVE Consulting, Gesamt-Projektkoordination):

Dr. Gerhard Renner, Ing. Mag. Alexander-Gregor Keller, MBA, Mag. Gerhard Gretzl

Ärzteteam:

Prim. Dr. Ludwig Neuner (Klinikum Freistadt, OÖG)

Fachleute aus den medizinischen Fächern

Statistik:

Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Karl P. Pfeiffer

Software-Entwicklung:

DI Bernhard Pesec (dothealth)

Gesundheit Österreich GmbH:

Mag. Petra Paretta, Dr. Florian Röthlin, Hermann Schmied, MPH, Dr. Wolfgang Seebacher

Wien, im Dezember 2025

Copyright und Haftung:

Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig.

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des BMASGPK und der Autorin/des Autors ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin/des Autors dar und können der Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgreifen.

Bestellinfos: Diese und weitere Publikationen sind kostenlos über das Broschürenservice des Sozialministeriums unter <http://www.sozialministerium.gv.at/broschuerenservice>, zu beziehen.

Inhalt

Fragen zur Datenmeldung, zu Codierpflichten und Ausnahmeregelungen 6

Ab wann muss ich nach ICD-10 codierte Diagnosen übermitteln?.....	6
An welche Stelle und in welcher Form muss ich als Arzt/Ärztin mit Kassenvertrag die codierten Diagnosen übermitteln?.....	6
Sind Fachrichtungen von der ambulanten Leistungs- und Diagnosecodierung ausgenommen?.....	7
Ist es ausreichend, wie bisher die Daten – nunmehr mit ICD-10-Code(s) – an die Krankenversicherungsträger im Rahmen der Monats-/Quartalsabrechnung zu übermitteln?	7
Genügt es, einfach den entsprechenden Code der Diagnose nachzustellen und mit der Diagnose zu übermitteln, oder muss das in einem bestimmten Format geschehen?	7
Sind ausschließlich ICD-10-Diagnosen zu übermitteln oder dürfen auch Freitextdiagnosen in der Abrechnungsdatei enthalten sein und haben diese dann überhaupt noch eine Funktion?.....	8
Gilt die Verpflichtung zur Diagnosencodierung auch für Wahlärzte bzw. Privatärzte? Gibt es Ausnahmen?	8
Wie lange hat ein Arzt Zeit, die Diagnosen nach dem Besuch zu melden – gibt es eine Frist?	8
Muss der ICD-10-Code mit seinem Originaltext übermittelt werden? Kann der Text zum Code für interne Dokumentationszwecke geändert oder ergänzt werden, z.B. durch Informationen zum Schweregrad?.....	9
Mit WAHonline werden Leistung und Diagnose bereits an die jeweilige Krankenkasse übermittelt. Müssen die Leistungen gesondert an die Sozialversicherung übermittelt werden?	9
Ist die Datenübermittlung lt. DokuG über die e-Wahlpartner-Schnittstelle auch in der Weboberfläche der SV möglich?	10
Reicht die Übermittlung des ICD-Codes in der Weboberfläche der Sozialversicherung aus oder muss der Code aus dem SNOMED CT übermittelt werden?	10
Genügt es, um die gesetzliche Vorgabe zu erfüllen, eine ggf. gesicherte Hauptdiagnose pro ambulanten Besuch inkl. ICD-10-Code auf der Honorarnote der Sozialversicherung zu übermitteln? Was ist, wenn der Patient eine Einreichung der Honorarnote an die Sozialversicherung ablehnt?	10
Wie ist mit Klient:innen aus dem Bereich der ästhetischen Chirurgie bzw. dem ästhetischen Bereich (keine medizinische Indikation) zu verfahren?	11

Allgemeine und fachspezifische Fragen zur Diagnosencodierung..... 11

Wo finde ich Unterstützung bei der Diagnosencodierung?.....	11
Was kann ich tun, wenn ich den gesuchten Begriff nicht finden kann?	12
Wie werden Verlaufskontrollen bei chronischen Erkrankungen im Rahmen der Diagnosecodierung übermittelt?	12
Welcher Code ist zu übermitteln, wenn im Rahmen einer angiologischen Untersuchung z.B. der Verdacht auf eine PAVK, Thrombosen und venöse Insuffizienzen ausgeschlossen wurde?	12
Künstliche Gelenksprothesen müssen routinemäßig auch ohne Beschwerden in regelmäßigen Abständen (alle 5 Jahre) klinisch und radiologisch kontrolliert werden. Was ist dafür die richtige Codierung?	12
Welcher Code ist bei Impfungen als Kontaktgrund einzutragen?	13

Welcher Code ist als Kontaktgrund für (mehrmalige) Rezeptbestellungen zu verwenden?.....	13
Wie erfolgt die Verordnung von Suchtgiftmedikamenten über die e-Card?.....	13
Welche ICD-10-Codes sind für Krebsvorsorge und Nachsorgeuntersuchungen zu verwenden?	13
Gibt es Codes für die Kontaktgründe Vorsorgeuntersuchung und Kurantrag?	14
Welche ICD-10-Codes sind bei Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen zu übermitteln?	14
Was ist im Zusammenhang mit Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen der richtige ICD-10-Code für „Entwicklungsneurologischer Normbefund“?	15
ICD-10-Codierbeispiele für Kinderärztinnen und -ärzte.....	15
Wo findet man unabhängig vom Codierservice das Handbuch Medizinische Dokumentation für den extramuralen ambulanten Bereich (Diagnosecodierung) und den vollständigen Diagnose-Katalog für die verpflichtende Codierung ab 1.1.26?	18
Kann man das das Handbuch Medizinische Dokumentation für den extramuralen ambulanten Bereich auch als Druckexemplar bestellen?	19

Fragen zur Datenmeldung, zu Codierpflichten und Ausnahmeregelungen

Ab wann muss ich nach ICD-10 codierte Diagnosen übermitteln?

Ab 1.7.2026 ist zu jedem ambulanten Kontakt mindestens ein ICD-10-Code zu erfassen, der den medizinischen Grund für den Kontakt beschreibt und im Zuge der Datenmeldung für das 3. Quartal zu übermitteln. Eine freiwillige Erfassung und Meldung ist bereits ab 1. Jänner 2026 möglich und soll für die Pilotierung genutzt werden.

An welche Stelle und in welcher Form muss ich als Arzt/Ärztin mit Kassenvertrag die codierten Diagnosen übermitteln?

Als Vertragspartner der KV-Träger ÖGK, SVS und BVAEB übermitteln Sie die codierten Diagnosen mit Ihren Leistungsabrechnungen im Wege von ELDA/DVP an den jeweils zuständigen KV-Träger Ihrer Patient:innen.

Im DVP-Datensatz sind mehrere Arten von Diagnoseübermittlungen möglich (daran hat die Änderung der Organisationsbeschreibung für das DokuG nichts geändert).

Es wird mit dem Diagnosekennzeichen (DIAKZ 1–3) festgelegt, welcher Inhalt im Diagnosefeld (DIAGN) übermittelt wird.

Folgende Möglichkeiten bestehen derzeit:

- Codierungen: ICD-10, ICD-9, ICPC2, RC-Code und
- Diagnosetext

Wenn in der Abrechnung das Kennzeichen für ICD-10 übermittelt wird, wird im Diagnosefeld auch ein gemäß der Beschreibung formatierter ICD-10-Code erwartet.

Wird in der Abrechnung das Kennzeichen für Diagnosetext übermittelt, so wird der Inhalt des Diagnosefeldes als Text interpretiert.

Dies bedingt auch eine Anpassung Ihrer bestehenden Ordinationssoftware.

CAVE: Für die Übermittlung von Diagnosen (Hauptdiagnose und optionale Zusatzdiagnosen) gemäß den Bestimmungen des Gesundheitsdokumentationsgesetzes (DokuG) sind ausschließlich ICD-10-Codes zulässig.

Für andere Zwecke können im DVP-Datensatz auch andere Codes und Freitext mitübermittelt werden.

Fachlich-operative Fragen an die SV im Zusammenhang mit der Umsetzung der extramuralen Diagnosen- und Leistungsdatenmeldung (inkl. HONO-IDs) richten Sie bitte an leidap@sozialversicherung.at.

Die Veröffentlichung der DVP finden Sie unter

<https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.821515&portal=svportal>.

Sind Fachrichtungen von der ambulanten Leistungs- und Diagnosecodierung ausgenommen?

Nein, die ambulante Leistungs- und Diagnosecodierung umfasst alle Fachrichtungen.

Ist es ausreichend, wie bisher die Daten – nunmehr mit ICD-10-Code(s) – an die Krankenversicherungsträger im Rahmen der Monats-/Quartalsabrechnung zu übermitteln?

Ja, die Diagnosen sind zu jedem ambulanten Besuch (Kontakt) eines Patienten/einer Patientin einmal pro Tag (mit Datum) zu erfassen (mindestens eine Diagnose, mehrere Zusatzdiagnosen sind möglich) und im Rahmen der Monats-/Quartalsabrechnung an die Krankenversicherungsträger zu übermitteln.

Genügt es, einfach den entsprechenden Code der Diagnose nachzustellen und mit der Diagnose zu übermitteln, oder muss das in einem bestimmten Format geschehen?

Wenn Sie Vertragspartner eines oder mehrerer KV-Träger sind und Ihre Abrechnungsdaten inkl. Honorarposition/en der erbrachten Leistung/en über die DVP-Schnittstelle des DVSV an den KV-Träger übermitteln, bei dem Ihr:e Patient:in versichert ist, so wird der DVP-Datensatz künftig ein angepasstes Diagnosenmodul mit einem Diagnosefeld für ICD-10-Codes haben. Dazu ist auch eine Anpassung in Ihrer Ordinationssoftware unumgänglich.

Bei Nutzung des von BMASGPK und ELGA GmbH kostenfrei angebotenen e-Health-Codierservices kann Freitext, der ohnehin für die interne Patientenakte dokumentiert werden muss, in standardisierte Codes überführt werden. Eine einfache Wiederverwendung von Codes bei wiederholten Besuchen aus denselben Gründen sollte durch die Ordinationssoftware unterstützt werden.

Das e-Health-Codierservice (<https://codierservice.ehealth.gv.at>) ist in die Ordinationssoftware integrierbar, kann diese jedoch nicht ersetzen. Es steht aber auch als Webapplikation zur Verfügung.

Wie eine optionale, nicht verpflichtende Integration des Codierservices erfolgen kann und zu welchen Kosten, liegt in der Verantwortung Ihres Softwareanbieters.

Aufgrund der Unterschiedlichkeit der angebotenen Systeme ist es weder dem DVSV noch dem BMASGPK möglich, hier technische Vorgaben zu machen oder Preisempfehlungen

abzugeben. Wir haben jedoch bei verschiedenen Gelegenheiten an die Softwareanbieter appelliert, den Anwender:innen ihrer Produkte auch eine direkte Dateneingabe zu ermöglichen.

Sind ausschließlich ICD-10-Diagnosen zu übermitteln oder dürfen auch Freitextdiagnosen in der Abrechnungsdatei enthalten sein und haben diese dann überhaupt noch eine Funktion?

Für die nach dem DokuG verpflichtende Datenübermittlung sind ausschließlich ICD-10-Codes zu übermitteln, kein Freitext. Bei mehreren Codes wird der erste Code als Hauptdiagnose interpretiert. Über das Codierservice sollten auch mehrere Codes abgefragt werden können.

Die Krankenversicherungsträger verbieten nicht – weder technisch noch fachlich – das Übermitteln von Freitextdiagnosen zusätzlich zu den für das DokuG verpflichtenden ICD-10-Codes.

Gilt die Verpflichtung zur Diagnosencodierung auch für Wahlärzte bzw. Privatärzte? Gibt es Ausnahmen?

Für Wahlärzte bzw. Privatärzte (Ärzte ohne Kassenvertrag) gilt die Verpflichtung zur Codierung von Diagnosen nach ICD-10 und von codierten Leistungen, sofern diese sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähig sind, sowie deren Übermittlung im Wege der e-Wahlpartnerschnittstelle des DVS, außer es besteht für sie keine Pflicht zur Nutzung der Schnittstelle gemäß § 49 Abs. 7 Z 1 des Bundesgesetzes über die Ausübung des ärztlichen Berufes und die Standesvertretung der Ärzte (ÄrzteG 1998), BGBl. I Nr. 169/1998 idGF (e-Card-Infrastruktur). Das ist gem. einer Festlegung des BMASGPK der Fall, wenn sie weniger als 300 unterschiedliche Patient:innen pro Jahr behandeln.

Sowohl das Dokumentationsgesetz als auch das Ärztegesetz sehen keine Unterscheidung zwischen „Wahlärzten“ und „Privatärzten“. Auch die Ärztekammer unterscheidet nur Ärzte/Ärztinnen mit oder ohne Kassenverträge.

Wie lange hat ein Arzt Zeit, die Diagnosen nach dem Besuch zu melden – gibt es eine Frist?

Für Ärzte/Ärztinnen mit Kassenverträgen gilt: Die Diagnosen sind zu jedem ambulanten Besuch (Kontakt) eines Patienten/einer Patientin einmal pro Tag (mit Datum) zu codieren (mindestens eine Hauptdiagnose, mehrere Zusatzdiagnosen sind möglich) und mit der Monats-/Quartalsmeldung zu übermitteln.

Ärzte/Ärztinnen ohne Kassenverträge haben ebenfalls zu jedem ambulanten Besuch (Kontakt) eines Patienten/einer Patientin einmal pro Tag (mit Datum) Diagnosen (mindestens eine Hauptdiagnose, mehrere Zusatzdiagnosen sind möglich) und Leistungen zu codieren und im Wege der e-Wahlpartnerschnittstelle des DVSV zu übermitteln. Die Frist zur allfälligen nachträglichen Bearbeitung der Kontakte (und dazugehörenden Diagnosen und Leistungen) und zur Datenübermittlung beträgt längstens

- für das 1. Quartal bis zum 31. Mai
- für das 2. Quartal bis zum 31. August
- für das 3. Quartal bis zum 30. November
- für das 4. Quartal bis zum 28. Februar des folgenden Jahres.

Muss der ICD-10-Code mit seinem Originaltext übermittelt werden? Kann der Text zum Code für interne Dokumentationszwecke geändert oder ergänzt werden, z.B. durch Informationen zum Schweregrad?

Für die Übermittlung gemäß DokuG ist der ICD-10-Code ausreichend. Der Originaltext des ICD-10-Codes ergibt sich aus dem übermittelten Code und wird nicht zusätzlich übermittelt.

Zur Übermittlung von Schweregraden können bei Bedarf auch die in der ICD-10 abgebildeten 5-Steller verwendet werden. Zu Aufbau und Struktur der Patientendokumentation gibt es seitens des DokuG keine Vorgaben. Es können dort auch detailliertere Informationen wie SNOMED-CT-Begriffe hinterlegt werden.

Die Art der Übermittlung von Schweregradinformationen an den Krankenversicherungsträger ist vom DokuG grundsätzlich nicht betroffen.

Mit WAHonline werden Leistung und Diagnose bereits an die jeweilige Krankenkasse übermittelt. Müssen die Leistungen gesondert an die Sozialversicherung übermittelt werden?

Das Gesundheitsdokumentationsgesetz (DokuG) regelt den Weg der Datenlieferung in Bezug auf die Übermittlung der Leistungs- und Diagnosecodierung. In diesem Gesetz ist angeführt, dass die Daten der Leistungserbringer (LE) ohne Kassenvertrag über eine vom Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV) zur Verfügung gestellte Schnittstelle zu melden sind. Dafür hat der DVSV das eCard-Service e-Wahlpartner umgesetzt. Die WAH-Online entspricht nicht dem gesetzlichen Datenmeldeweg lt. DokuG, daher hat sie für diesen Datenmeldeweg keine Relevanz.

Ist die Datenübermittlung lt. DokuG über die e-Wahlpartner-Schnittstelle auch in der Weboberfläche der SV möglich?

Wenn die Daten lt. DokuG über die e-Wahlpartner-Schnittstelle zu übermitteln sind, so kann man als LE entweder die Schnittstelle als Softwareintegration für die Erfassung und Meldung aller Daten nützen, oder alle erforderlichen Daten einschließlich Leistungen und Diagnosen über die e-card-Weboberfläche erfassen und übermitteln.

Technische Fragen im Zusammenhang mit e-Wahlpartner richten Sie bitte an support@svc.co.at.

Die Veröffentlichung der Informationen und der FAQs zu e-Wahlpartner finden Sie unter <https://www.chipkarte.at/cdscontent/?contentid=10007.907624&portal=ecardportal>.

Reicht die Übermittlung des ICD-Codes in der Weboberfläche der Sozialversicherung aus oder muss der Code aus dem SNOMED CT übermittelt werden?

Für die Übermittlung von Diagnosen über die e-card Web-Oberfläche (Service e-Wahlpartner) ist kein SNOMED-CT-Code, sondern ausschließlich der ICD-10-Code zu melden.

Genügt es, um die gesetzliche Vorgabe zu erfüllen, eine ggf. gesicherte Hauptdiagnose pro ambulanten Besuch inkl. ICD-10-Code auf der Honorarnote der Sozialversicherung zu übermitteln? Was ist, wenn der Patient eine Einreichung der Honorarnote an die Sozialversicherung ablehnt?

Die Meldung lt. Bundesgesetz über die Dokumentation im Gesundheitswesen (DokuG) ist unabhängig von der Meldung, die im Rahmen der Wahlarztkostenerstattung über die Schnittstelle WAHOnline an die Krankenversicherungsträger erfolgt. Jegliche Regelungen für die Meldung im Rahmen der Kostenerstattung über die Schnittstelle WAHOnline sind vom DokuG unberührt.

Die Meldung lt. DokuG zielt auf die Meldung von Kontakten, Diagnosen und Leistungen über den Weg des Dachverbandes mittels des Services e-Wahlpartner an das BMASGPK ab. Die Leistungen müssen vom Leistungserbringenden aus einem Honorarkatalog der Krankenversicherungsträger ausgewählt werden. Es erfolgt auch keine Kostenerstattung über diesen Meldeweg, weil er damit wie oben beschrieben nichts zu tun hat.

Für Ärzte/Ärztinnen ohne Kassenvertrag stehen die [Services für e-card Basis-Wahlpartner](#) unter chipkarte.at zur Verfügung. Wenn Sie für Ihre Patientenakten eine Ordinationssoftware nutzen, so sollten darin alle für die Übermittlung von Leistungs-, Diagnosen- und Kontaktdaten benötigten Informationen enthalten sein und Sie könnten von Ihrem Anbieter die Schnittstelle zum Service für e-Wahlpartner Ihrer Wahl in Ihre Arzt-Software

integrieren lassen. Wenn Sie das nicht wollen, so steht Ihnen ab 1.1.2026 e-Wahlpartner auf der eCard-Web-Oberfläche zur Verfügung. Voraussetzung zur Nutzung ist eine vorhandene eCard-Ausstattung. Das Handbuch zur Nutzung wird rechtzeitig auf chipkarte.at veröffentlicht.

Die Leistungs- und Diagnosecodierung per 01.01.2026 ist für Sie als Wahlarzt auch dann verpflichtend, wenn die betroffenen Patient:innen Ihre Honorarnote nicht einreichen möchten, sofern es sich um sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähige Leistungen handelt (z.B. Leistungen, für die es in der Honorarordnung eines KV-Trägers eine Abrechnungsposition gibt).

Soweit für Sie allerdings keine Pflicht zur Nutzung der Schnittstelle gemäß § 49 Abs. 7 Z 1 des Bundesgesetzes über die Ausübung des ärztlichen Berufes und die Standesvertretung der Ärzte (ÄrzteG 1998), BGBl. I Nr. 169/1998 idgF (e-Card-Infrastruktur) besteht, besteht auch keine Pflicht zur Übermittlung der Daten nach dieser Bestimmung. Das ist gem. einer Festlegung des BMASGPK der Fall, wenn Sie weniger als 300 unterschiedliche Patient:innen pro Jahr behandeln.

Wie ist mit Klient:innen aus dem Bereich der ästhetischen Chirurgie bzw. dem ästhetischen Bereich (keine medizinische Indikation) zu verfahren?

Für Leistungen aus dem Bereich der ästhetischen Chirurgie bzw. dem ästhetischen Bereich ohne medizinische Indikation besteht keine Codier- und Meldepflicht, da diese nicht sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähig sind.

Allgemeine und fachspezifische Fragen zur Diagnosencodierung

Wo finde ich Unterstützung bei der Diagnosencodierung?

Wir möchten Sie gerne darauf hinweisen, dass das Gesundheitsministerium und die ELGA GmbH gemeinsam das e-Health-Codierservice entwickelt haben, den wir kostenfrei zur Verfügung stellen und der über eine entsprechende Schnittstelle von Ihrem Softwareanbieter Ihr Ordinationssoftwaresystem integriert werden kann. Es steht aber auch als Webapplikation zur Verfügung.

Sie können das e-Health-Codierservice auch selbst testen; er läuft in einem produktiven Pilotbetrieb, in dem Suchbegriffe und validierte Überleitungen zu ICD-10-Codes (und SNOMED-CT-Codes für künftige e-Health-Anwendungen) laufend und über die Startphase der verpflichtenden ambulanten Codierung hinaus ergänzt werden.

Was kann ich tun, wenn ich den gesuchten Begriff nicht finden kann?

Viele Ordinationssoftwarepakete verwenden das e-Health Codierservice. Die für das e-Health Codierservice zur Verfügung gestellte Terminologie wird laufend ergänzt. Bei Ergänzungen ist kein Softwareupdate erforderlich. Hinweise der Anwender auf fehlende Begriffe sind wichtig und willkommen. Für die Eingabe fehlender Begriffe steht die Feedback-Funktion des e-Health-Codierservices unter dem folgenden Link zur Verfügung: <https://codierservice.ehealth.gv.at/feedback/>.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die eingemeldeten Begriffe nicht sofort zur Verfügung gestellt werden können, da zunächst die Zuordnung zu einem passenden SNOMED Konzept, ggf. die Übersetzung des Konzeptes sowie das Mapping auf ICD-10 erfolgen müssen, was Zeit beansprucht.

Wie werden Verlaufskontrollen bei chronischen Erkrankungen im Rahmen der Diagnosecodierung übermittelt?

Wenn der Anlass des ambulanten Besuchs immer die gleiche chronische Erkrankung bzw. deren Verlaufskontrolle ist, so ist auch immer die gleiche dazugehörige Diagnose zu übermitteln.

Welcher Code ist zu übermitteln, wenn im Rahmen einer angiologischen Untersuchung z.B. der Verdacht auf eine PAVK, Thrombosen und venöse Insuffizienzen ausgeschlossen wurde?

Bei einem ausgeschlossenen Verdacht auf PAVK, Thrombose etc. ist der folgende Code zu verwenden: Z03.5 Beobachtung bei Verdacht auf sonstige kardiovaskuläre Krankheiten.

Künstliche Gelenksprothesen müssen routinemäßig auch ohne Beschwerden in regelmäßigen Abständen (alle 5 Jahre) klinisch und radiologisch kontrolliert werden. Was ist dafür die richtige Codierung?

Die korrekte Codierung für die Routineuntersuchung einer Gelenksprothese, die aus orthopädischen Gründen implantiert wurde, ist

- Z09.0 Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen anderer Krankheitszustände und (als Zusatzdiagnose)
- Z96.6 Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten

Welcher Code ist bei Impfungen als Kontaktgrund einzutragen?

Für die Zwecke des DokuG ist es ausreichend, für Impfungen den Code „Z29.9 Prophylaktische Maßnahme, nicht näher bezeichnet“ als allgemeinen Grund für den Kontakt zu nennen. Alternativ kann ein passender ICD-10-Code aus U11, Z23 bis Z27 übermittelt werden, z.B. Z25.1 Notwendigkeit der Impfung gegen Grippe [Influenza].

Gesetzlich verpflichtet sind Ärztinnen und Ärzte sowie sonstige impfende Personen, Grippeimpfungen (Influenza), Corona-Schutzimpfungen (COVID-19), HPV-Impfungen (humane Papillomviren) und Impfungen gegen Mpox (früher: Affenpocken) **im e-Impfpass** ihrer Patient:innen zu dokumentieren. Eine verpflichtende Ausweitung auf alle Impfungen ist nicht geplant, alle anderen Eintragungen sind freiwillig.

Welcher Code ist als Kontaktgrund für (mehrmalige) Rezeptbestellungen zu verwenden?

Als Kontaktgrund für mehrmalige Rezeptbestellungen bietet sich „Z76.0! Ausstellung wiederholter Verordnung“ an:

Z76 Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen

Z76.0 Ausstellung wiederholter Verordnung

Wiederverordnung:

- Apparat
- Arzneimittel
- Brille

Exkl.: Ausstellung einer ärztlichen Bescheinigung (Z02.7)

Wiederverordnung von Kontrazeptiva (Z30.4)

Wie erfolgt die Verordnung von Suchtgiftmedikamenten über die e-Card?

Was die Verordnung von Suchtgiftmedikamenten über die **e-Card per e-Rezept** betrifft, dürfen wir Sie an die **e-Card Serviceline** verweisen, die telefonisch unter **050 124 33 22** und auch per **E-Mail an e-card Serviceline** erreichbar ist.

Für die Zwecke des DokuG geben Sie bitte den Code „Z76.0! Ausstellung wiederholter Verordnung“ als Anlass für den Kontakt an.

Welche ICD-10-Codes sind für Krebsvorsorge und Nachsorgeuntersuchungen zu verwenden?

Bei ambulanten Kontakten zur Krebsvorsorge ist Z00.0 zu übermitteln, bei ambulanten Kontakten zur Nachsorge nach Tumorthherapie ist Z08.9 (oder ein spezifischerer Code aus Z08) zu übermitteln.

Zur Info ein Auszug aus dem systemat. Verzeichnis der ICD-10:

Z00.0 Ärztliche Allgemeinuntersuchung

Ärztliche Gesundheitsuntersuchung

Check-up

Periodische Untersuchung (jährlich) (körperlich)

Vorsorgeuntersuchung o.n.A.

Exkl.: Allgemeine Reihenuntersuchung bestimmter Bevölkerungsgruppen (Z10.-)

Vorsorgeuntersuchung eines Säuglings oder Kindes (Z00.1)

Für Nachsorgeuntersuchungen:

Z08 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung

Inkl.: Medizinische Überwachung im Anschluss an die Behandlung

Exkl.: Medizinische Nachbetreuung und Rekonvaleszenz (Z42-Z51, Z54.-)

Z08.0 Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung

Z08.1 Nachuntersuchung nach Strahlentherapie wegen bösartiger Neubildung

Exkl.: Strahlentherapie-Sitzung (Z51.0)

Z08.2 Nachuntersuchung nach Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung

Exkl.: Chemotherapie-Sitzung (Z51.1)

Z08.7 Nachuntersuchung nach Kombinationstherapie wegen bösartiger Neubildung

Z08.8 Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen bösartiger Neubildung

Z08.9 Nachuntersuchung nach nicht näher bezeichneter Behandlung wegen bösartiger Neubildung

Gibt es Codes für die Kontaktgründe Vorsorgeuntersuchung und Kurantrag?

Für eine **Vorsorgeuntersuchung** ist der ICD-10-Code **Z00.0 Ärztliche Allgemeinuntersuchung** zu übermitteln, für einen **Kurantrag** der Code **Z02.7 Ausstellung einer ärztlichen Bescheinigung**.

Welche ICD-10-Codes sind bei Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen zu übermitteln?

Der ICD-10-Code für die **Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen** bei Kindern lautet **Z00.1 Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eines Kindes**.

Was ist im Zusammenhang mit Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen der richtige ICD-10-Code für „Entwicklungsneurologischer Normbefund“?

Für den Begriff „**Entwicklungsneurologischer Normbefund**“ ist bei der Datenmeldung der ICD-10-Code **Z00.1** zu übermitteln.

Auszug aus dem systematischen Verzeichnis der ICD-10:

Z00.1 Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eines Kindes

Prüfung des Entwicklungsstandes eines Säuglings oder Kindes

ICD-10-Codierbeispiele für Kinderärztinnen und -ärzte

Allgemeine Hinweise zur Auswahl der Hauptdiagnose:

- Als Hauptdiagnose ist die Diagnose auszuwählen, die den medizinischen Grund für den ambulanten Besuch am besten beschreibt.
- Für die Auswahl der Hauptdiagnose ist der Kenntnisstand am Ende des ambulanten Besuchs relevant.
- Bei der Auswahl der Hauptdiagnose gilt die folgende Rangfolge:
Diagnose/Krankheitsbegriff > Symptom/auffälliger Befund > Andere Anlässe (Z-Codes wie z.B. Vorsorgeuntersuchung).

1. Kind kommt angemeldet zur Eltern-Kind-Pass-Untersuchung: Z00.1 Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eines Kindes.

Bei dem Kontakt berichtet die Mutter, dass er seit 3 Tagen Fieber hat und hustet, nach Untersuchung: J06.9 Akute Infektion der oberen Atemwege.

Dann berichtet die Mutter, dass seit 4 Wochen dauernd Bauchschmerzen bestehen:

R10.4 Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen.

Auf Nachfrage besteht auch „seit Wochen“ eine Verstopfung: K59.0 Obstipation.

Was soll davon als Kontaktgrund/Hauptdiagnose gewählt werden?

Antwort 1:

J06.9 Akute Infektion der oberen Atemwege = Hauptdiagnose

K59.0 Obstipation kann, muss aber nicht als Zusatzdiagnose mitgegeben werden.

R10.4 Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen kann, muss aber nicht als Zusatzdiagnose mitgegeben werden.

Z00.1 Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eines Kindes kann, muss aber nicht als Zusatzdiagnose mitgegeben werden.

Anmerkung: Die akute Infektion der oberen Atemwege ist die beim Kontakt festgestellte schwerwiegendste Gesundheitsstörung (Diagnose). Codes, die verwendet werden sollen, um einen Grund für den Kontakt angeben zu können, wenn keine

Gesundheitsstörung vorliegt (z.B. Gesundheitsvorsorgeuntersuchung), sind somit in dem Fall nicht notwendig.

2. Was wäre bei demselben Patienten zu wählen, wenn die Mutter den Termin primär wegen Fieber vereinbart hätte, die weiteren Fragestellungen aufgetreten wären und - weil es zeitlich passend gewesen wäre - auch die Eltern-Kind-Pass-Untersuchung bei demselben Kontakt gleich zusätzlich durchgeführt worden wäre (im Sinne eines One-Stop -Shop)?

Antwort 2:

Wie oben, die beim Kontakt festgestellte schwerwiegendste Gesundheitsstörung ist die Hauptdiagnose, die Angabe der Eltern-Kind-Pass-Untersuchung ist daher nicht notwendig.

3. Welche Diagnose hat Priorität bei grippalem Infekt mit Fieber?

J06.9 Akute Infektion der oberen Atemwege (Diagnose)

R50.9 Fieber n.n.b.

Diagnose J06.9 vor Symptom Fieber R50.9?

Antwort 3:

J06.9 Akute Infektion der oberen Atemwege = Hauptdiagnose

(Diagnose/Krankheitsbegriff > Symptom/auffälliger Befund); das Fieber kann, muss aber nicht als Zusatzdiagnose mitgegeben werden.

4. Was ist zu codieren, wenn 2 Diagnosen bestehen, z.B.

J06.9 Akute Infektion der oberen Atemwege

J02.0 Streptokokkenpharyngitis

Antwort 4:

J02.0 Streptokokkenpharyngitis = Hauptdiagnose

Die spezifischere Diagnose bzw. die schwerwiegendere Erkrankung sollte die Hauptdiagnose sein, weitere Diagnosen können als Zusatzdiagnose mitgegeben werden.

5. Eltern kommen wegen EINES Rezepts (Z76.0 Ausstellung wiederholter Verordnung), aber das Kind hat auch Fieber und bei Untersuchung eine Influenza A (J10.1).

Antwort 5:

Wie oben: J10.1 Influenza A ist die Hauptdiagnose, ein weiterer unspezifischer Grund wie Z76.0 ist nicht mehr notwendig.

6. Welche Diagnose ist für eine Gedeihkontrolle zu wählen (Kontrolle von Größe + Gewicht + klinische Untersuchung), ohne dass das Kind krank ist?

Ausschluss Probleme mit Gewichtsentwicklung, Untergewicht, Übergewicht, Adipositas

Z00.1 Gesundheitsvorsorgeuntersuchung?

Z00.8 Sonstige Allgemeinuntersuchungen?

Z01.9 Spezielle Untersuchung n.n.b.?

Antwort 6:

Da keine Gesundheitsstörungen vorliegen, ist „Z00.1 Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eines Kindes“ die passende Hauptdiagnose.

7. Wie codiere ich Ernährungsberatung beim Säugling (welche Milch in welchem Alter, Einführung Beikost oder ähnliches)?

Antwort 7:

„Z71.9 Beratung, nicht näher bezeichnet“ ist hier die passende Hauptdiagnose.

8. Wie codiere ich: Kommt zur Grippeimpfung (Z29.9 sonstige prophylaktische Maßnahme n.n.b.), zeitgleich Gedeihkontrolle Z00.1 (s. Punkt 6), dabei Feststellung ausgeprägter Adipositas (E66.95 extreme Adipositas bei Kindern 3–18 Jahre) und ausführliche Beratung zu Ernährung und Lebensstil?

Antwort 8:

Der als Hauptdiagnose zu übermittelnde Code ist „E66.9 Adipositas, nicht näher bezeichnet“.

Es wurde beim Kontakt eine Gesundheitsstörung (Adipositas) festgestellt, die die Hauptdiagnose ist. Die Übermittlung von ICD-10 Codes für die Impfung (Z29.9) und die Gedeihkontrolle (Z00.1) ist bei Vorliegen einer Gesundheitsstörung nicht notwendig.

Bitte zu beachten: in Österreich gibt es im Kapitel E65–E68 keine Fünfsteller, diese sind nur in Deutschland gebräuchlich. Daher gibt es hier keine Unterscheidung nach Altersgruppen bzw. BMI.

9. Wie codiere ich extreme Adipositas unter 3 Jahren?

Antwort 9:

„E66.9 Adipositas, nicht näher bezeichnet“, siehe vorhergehende Frage.

10. Wie codiere ich eine Entwicklungskontrolle bei Zustand nach extremer Frühgeburtlichkeit P07.2?

- a) in den ersten Lebensmonaten: Kind klinisch unauffällig
- b) im Alter von 2 Jahren, Kind klinisch unauffällig
- c) Kind auffällig: Diagnose je nach Entwicklungsauffälligkeit ist klar

Antwort 10:

Ohne Auffälligkeit ist die Entwicklungskontrolle zu codieren, die Frühgeburtlichkeit ist nicht mehr anzugeben:

- a) Z00.1 Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eines Kindes
- b) Z00.1 Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eines Kindes
- c) jeweilige Gesundheitsstörung, die festgestellt wurde

- 11.** Wie codiere ich bei Durchführung der Hüftsonografie des Säuglings, wenn sich ein unauffälliger Befund ergibt:
- a) im Rahmen der Eltern-Kind-Pass-Untersuchung: Z00.1 Gesundheitsvorsorgeuntersuchung beim Kind?
 - b) Wenn die Hüftsonografie bei der Eltern -Kind-Pass-Untersuchung auffällig war (Hüftdysplasie) und es wird eine Kontrolle 4 Wochen später durchgeführt (dann nicht mehr Eltern -Kind-Pass), aber bei Kontrolle ist der Befund unauffällig geworden?

Antwort 11:

- a) „Z00.1 Gesundheitsvorsorgeuntersuchung eines Kindes“
- b) „Q65.8 Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte“ für die Hüftdysplasie und nach 4 Wochen „Z03.8 Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen“ bei der Kontrolle mit unauffälligem Befund

Wo findet man unabhängig vom Codierservice das Handbuch Medizinische Dokumentation für den extramuralen ambulanten Bereich (Diagnosecodierung) und den vollständigen Diagnose-Katalog für die verpflichtende Codierung ab 1.1.26?

Sie finden das Handbuch Medizinische Dokumentation für den extramuralen ambulanten Bereich (Diagnosecodierung) und weitere Infos zur ambulanten Diagnosencodierung unter <https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem-und-Qualitaetssicherung/Dokumentation/Ambulante-Leistungs-und-Diagnosendokumentation.html>. Hier stellen wir auch den Diagnoseschlüssel ICD-10 BMASGPK 2026 als maschinenlesbare Exceltabelle [DIAGLIST 2026 \(Excel, 1022 KB\)](#) zur Verfügung sowie eine gekürzte, auf den Bedarf niedergelassener GDA abgestimmte Tabelle: [ICD-10 Extramural \(Excel, 398 KB\)](#).

Das [ICD-10 BMASGPK 2026 – SYSTEMATISCHES VERZEICHNIS \(PDF, 4 MB\)](#) und die [ICD-10 BMASGPK 2026 – ALPHABETISCHES VERZEICHNIS \(Excel, 3 MB\)](#) finden Sie unter <https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Krankenanstalten/LKF-Modell-2026/Kataloge-2026.html>. Beide Websites werden anlassbezogen aktualisiert.

Noch ein Tipp: Ihr Softwareanbieter könnte auch die Schnittstelle zu unserem kostenfrei zur Verfügung gestellten [e-Health-Codierservice](#) in Ihrem Ordinationssoftwaresystem integrieren; diese Serviceleistung ist allerdings kostenpflichtig. Sie können das [e-Health-Codierservice](#) derzeit auch in einem produktiven Pilotbetrieb selbst testen.

Kann man das das Handbuch Medizinische Dokumentation für den extramuralen ambulanten Bereich auch als Druckexemplar bestellen?

Wir bitten um Verständnis, dass die Herstellung von Druckexemplaren derzeit nicht vorgesehen ist; insbesondere, weil es aktuell und auch in den ersten Monaten nach Inkrafttreten der Codierpflicht in kurzen Abständen zu Anpassungen, Präzisierungen und Ergänzungen kommen kann, die durch in der praktischen Anwendung auftretende Fragestellungen notwendig werden können. Gedruckte Exemplare würden dadurch schnell veralten und unbrauchbar werden.

Sie finden das Handbuch Medizinische Dokumentation für den extramuralen ambulanten Bereich (Diagnosecodierung) und weitere Infos zur ambulanten Diagnosencodierung unter <https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitssystem-und-Qualitaetssicherung/Dokumentation/Ambulante-Leistungs--und-Diagnosendokumentation.html>.



**Bundesministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz**

Stubenring 1, 1010 Wien

+43 1 711 00-0

sozialministerium.gv.at